TOSCANA DIAGNOSTICA

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

ISTRUZIONE DI LAVORO
MODALITÀ DI RACCOLTA, GESTIONE E INVIO DI CAMPIONI DI ANATOMIA PATOLOGICA

Area 18 – Laboratorio

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-IDL014_00	00	14/04/2026	12
Redatto da	**Approvato da**	**Classificazione**	**Stato**
Anatomia Patologica / Lab Ops / RSGI	AD – Francesco Epifani	Distribuito	In vigore

Rif.: ISO 15189:2022 cl. 5.3-5.4 · TD-SGI-IDL011 (Prelievo e Trasporto) · TD-SGI-IDL010 (Transbag Gialla per AnaPath) · TD-SGI-MOD043 (Bolla Trasporto) · TD-SGI-MOD056 (Invio Campioni AnaPath) · TD-SGI-MOD058 (Scheda Istopatologia) · TD-SGI-MOD059 (Scheda Citologia Generale) · TD-SGI-MOD061 (Scheda Citologia Ginecologica) · TD-SGI-MOD062 (Scheda Citologia Urinaria) · TD-SGI-PRO035 (Logistica)

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Valentina Zezza	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
04/05/2026	04/05/2026	04/05/2026

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

1. Scopo e campo di Applicazione

L'obiettivo della presente Istruzione di Lavoro è fornire gli strumenti e le informazioni per la raccolta, la gestione e l'invio dei campioni di Anatomia Patologica, di norma più complessi dei campioni biologici più comuni.

2. Materiali e modalità di raccolta

Pap Test in Fase Liquida: MONOSTRATO, NEWPAP RNA, NEWPAP DNA, TRIPAP, HPV RNA, FULL PAP

- Preparazione: consigliare alle pazienti di non utilizzare farmaci per via vaginale (candelette, ovuli, creme, lavande), eventuali terapie locali vanno sospese almeno 3 giorni prima dell'esecuzione del test; consigliare alle pazienti di non avere rapporti sessuali nei 3 giorni precedenti all'esame.
- è assolutamente sconsigliato l'uso del lubrificante, il lubrificante interferisce con la preparazione e la refertazione del Pap test.
- Il materiale citologico deve essere inviato stemperato nell'apposito contenitore con fissativo, che viene fornito dal nostro magazzino.
- Il cyto-brush dopo il prelievo deve essere agitato energicamente, direttamente nel contenitore (Thin Prep) e strisciato lungo le pareti in modo da far staccare il maggior numero di cellule possibile.
- NON lasciare il cyto-brush all'interno del contenitore (Thin Prep)
- Scrivere in matita o con penne/pennarelli con inchiostro indelebile: nome, cognome e data di nascita della paziente sull'etichetta del contenitore Thin Prep.
- Qualora l'accettazione non avvenga tramite sistema interfacciato, è necessario compilare la scheda d'accettazione dedicata in tutte le sue parti.

Materiale Cervico Vaginale

Pap test convenzionale

- Preparazione: consigliare alle pazienti di non utilizzare farmaci per via vaginale (candelette, ovuli, creme, lavande); eventuali terapie locali vanno sospese almeno 3 giorni prima dell'esecuzione del test; è assolutamente sconsigliato l'uso del lubrificante, poiché il lubrificante interferisce con la preparazione e la refertazione del Pap test. Consigliare alle pazienti di non avere rapporti sessuali nei 3 giorni precedenti all'esame. La sequenza:
- Utilizzare un unico vetrino con angoli smussati e banda sabbiata;
- Scrivere a matita nome, cognome e data di nascita della paziente sulla banda sabbiata;
- Strisciare il materiale sul vetrino in modo da avere uno strato il più possibile sottile, senza macro-aggregati
- Il materiale deve essere strisciato sullo stesso lato sul quale è scritto: cognome, nome e data di nascita;
- Il vetrino deve essere subito fissato con citospray;
- Il vetrino deve essere posto in porta-vetrini idonei (eventualmente da richiedere a magazzino), si sconsiglia l'uso di porta-vetrini in cartone;
- qualora venga utilizzato un unico porta-vetrini per più campioni le superfici dei vetrini non devono essere a contatto;
- Qualora l'accettazione non avvenga tramite sistema interfacciato, è necessario compilare la scheda d'accettazione dedicata in tutte le sue parti.

Si consiglia di preferire sempre come metodica quella in fase liquida, essendo più efficace, meno soggetta a inadeguatezza del campione e permette anche l'analisi dallo stesso dei ceppi HPV.

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

Ricerca HPV DNA, Metodo PCR

- Se l'esame richiesto è associato al Pap test in fase liquida (NEW PAP DNA, TRIPAP, Monostrato+HPV DNA con PCR) è sufficiente l'invio del materiale raccolto in un unico contenitore per la raccolta della fase liquida, ovvero Thin Prep.
- In caso di SOLA ricerca e tipizzazione HPV DNA con metodo PCR senza esecuzione del Pap-Test, inviare i campioni come previsto dalle modalità di "invio e trasporto in service".
- Qualora l'accettazione non avvenga tramite sistema interfacciato, è necessario compilare la scheda d'accettazione dedicata in tutte le sue parti.

Materiale Endometriale

Citologico Endometriale in fase liquida

Il materiale citologico deve essere inviato stemperato nell'apposito contenitore (Thin Prep PreservCyt Solution) con fissativo fornito dal nostro magazzino. Scrivere in matita o con penne/pennarelli con inchiostro indelebile: nome, cognome e data di nascita della paziente sull'etichetta del contenitore.

Qualora l'accettazione non avvenga tramite sistema interfacciato, è necessario compilare la scheda d'accettazione dedicata in tutte le sue parti.

Urine

Esame citologico urinario

Per la raccolta si raccomanda di eseguire scrupolosamente le seguenti istruzioni:

Scartare la prima urina del mattino;

Raccogliere la seconda urina (seconda emissione) nel contenitore Cytolyt fornito dal magazzino;

Riempire il contenitore con almeno 30ml di urine;

Ripetere l'intera procedura per tre giorni consecutivi.

Al termine dei 3 giorni di raccolta consegnare al laboratorio i 3 campioni e la scheda d'accettazione adeguatamente compilata in ciascuna sua parte. Una precisa raccolta delle notizie cliniche è sostanziale per una corretta diagnosi citologica.

ATTENZIONE: La soluzione presente nel contenitore per la raccolta del campione ha funzione di conservante; pertanto, non va gettata né dispersa nell'ambiente (in caso di non utilizzo i contenitori sarebbe opportuno riconsegnarli). Alcune sostanze componenti il conservante allo stato puro, risultano tossiche o infiammabili. Si consiglia comunque di: conservare i contenitori chiusi a temperatura ambiente (15-25°C) lontano da fonti di calore e da fiamme, non ingerire, evitare il contatto con la pelle ed occhi e conservare fuori dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua e con soluzione oftalmica decongestionante. In caso d'ingestione bere molta acqua, evitare emetici, latte o carbone, consultare un medico presentando questo foglio.

I campioni biologici non devono necessariamente essere tenuti in frigorifero, l'importante è che non siano sottoposti a temperature troppo elevate (consigliata la temperatura ambiente).

Qualora l'accettazione non avvenga tramite sistema interfacciato, è necessario compilare la scheda d'accettazione dedicata in tutte le sue parti. Si ricorda che un'accurata raccolta delle notizie cliniche è fondamentale per una corretta diagnosi citologica.

Espettorato per Ricerca Cellule Neoplastiche, Asbesto e Siderociti

Esame espettorato

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

L'espettorato deve essere raccolto al mattino in un contenitore a bocca larga, reperibile anche in farmacia, recante nome e cognome del paziente scritti in matita o con penne/pennarelli con inchiostro indelebile. Nel contenitore deve essere aggiunta, prima dell'espettorazione o immediatamente dopo, una soluzione di alcol 70-95° in quantità tale da ricoprire completamente il materiale espettorato; in alternativa, ma solo in assenza di alcol, il paziente può espettorare direttamente nei contenitori pre-riempiti di Cytolyt Solution 30 mL forniti da Toscana Diagnostica. Per i soggetti la cui raccolta dell'espettorato risulta difficoltosa, si consiglia, nei due giorni precedenti l'esame, la somministrazione di mucolitici o espettoranti.

Il contenitore deve essere conservato a temperatura ambiente e riconsegnato il giorno successivo all'espettorazione.

La raccolta del materiale deve essere effettuata seguendo questo procedimento:

1. Sciacquare accuratamente il cavo orale con alcuni gargarismi effettuati con acqua;
2. Eseguire un'espettorazione profonda cercando di far salire il contenuto tracheo-bronchiale;
3. Raccogliere l'espettorato direttamente nel contenitore.

Qualora l'accettazione non avvenga tramite sistema interfacciato, è necessario compilare la scheda d'accettazione dedicata in tutte le sue parti.

AGOASPIRATI

Esame citologico agoaspirato Thinprep

Se necessario è possibile effettuare un risciacquo della siringa mediante lavaggio in soluzione Thin Prep o Cytolyt Solution, tali barattoli dovranno poi essere accuratamente identificati ed inviati in associazione ad eventuali vetri strisciati.

Qualora sia aspirato materiale particolarmente liquido, questo può essere fissato in alcol 50° in rapporto 1 a 1 col liquido da esaminare (es: 50 mL liquido + 50 mL di alcool 50%) oppure in soluzione Thin Prep Solution utilizzando i barattoli pre-riempiti forniti da Toscana Diagnostica (se la quantità di liquido aspirata risulta essere eccessiva si consiglia l'utilizzo di contenitori pre-riempiti di Cytolyt Solution 30 mL forniti da Toscana Diagnostica). Scrivere in matita o con penne/pennarelli con inchiostro indelebile: nome, cognome e data di nascita del/della paziente sull'etichetta del contenitore nel quale viene posto il liquido. Si chiede di non inviare il materiale nella siringa utilizzata per eseguire la manovra di agoaspirazione e soprattutto di non inviare per nessun motivo l'ago con cui il materiale è stato prelevato.

Qualora l'accettazione non avvenga tramite sistema interfacciato, è necessario compilare la scheda d'accettazione dedicata in tutte le sue parti.

Liquidi Biologici Vari

Esame citologico liquidi cavità corporee e cisti

Il liquido biologico proveniente da peritoneo, pleura, pericardio o formazione cistica, deve essere subito trasferito nel contenitore pre-riempito di Cytolyt Solution 30 mL fornito da Toscana Diagnostica, in alternativa può essere messo in un contenitore a bocca larga contenente una quantità di alcool 50% in rapporto 1 a 1 con il liquido da esaminare (es: 50 mL liquido + 50 mL di alcool 50%).

Qualora l'accettazione non avvenga tramite sistema interfacciato, è necessario compilare la scheda d'accettazione dedicata in tutte le sue parti.

Esame Citologico per Brushing o Scraping

Esame citologico di organi e/o tessuti in fase liquida

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

Per la metodica in fase liquida il materiale citologico deve essere subito stemperato nell'apposito contenitore Thin Prep Solution con 20 mL di liquido fissativo, fornito da Toscana Diagnostica (stemperare il cytobrush o la spazzola direttamente nel contenitore e poi scartare il cytobrush). Scrivere in matita o con penne/pennarelli con inchiostro indelebile: nome, cognome e data di nascita del/della paziente sull'etichetta del contenitore.

Qualora l'accettazione non avvenga tramite sistema interfacciato, è necessario compilare la scheda d'accettazione dedicata in tutte le sue parti.

Esame citologico di organi e/o tessuti convenzionale

Il materiale citologico deve essere strisciato sul vetrino con angoli smussati recante sulla banda sabbiata (scritto solo a matita) nome e cognome del paziente, sede e lateralità. Il vetrino deve essere subito fissato mediante immediata immersione nell'apposito contenitore con alcol 95° ed inviato in laboratorio nel contenitore stesso. Si consiglia la fissazione dei vetrini con materiale da agoaspirazione in alcol 95° utilizzando contenitori appositamente identificati con un bollino rosso (nei quali è stata inserita una guarnizione a garanzia della chiusura ermetica per evitare la fuoriuscita del fissativo), tali contenitori potranno essere richiesti al nostro magazzino precisando "CONTENITORI PER INVIO DI VETRI IN ALCOL". Per la sicurezza degli operatori addetti alla processazione del campione si sottolinea l'importanza di non inserire nei contenitori alcun tagliente o pungente (aghi).

Qualora l'accettazione non avvenga tramite sistema interfacciato, è necessario compilare la scheda d'accettazione dedicata in tutte le sue parti.

Si consiglia di preferire la metodica in fase liquida, più efficace.

Istologici

Il materiale istologico deve essere inviato integro e non tagliato inserendolo in contenitori con chiusura ermetica, a bocca larga e completamente immerso in formalina al 10%, rapporto 1:10 tra materiale e liquido fissativo. Il materiale deve essere fissato subito dopo il prelievo. In caso di utilizzo di contenitori pre-riempiti di formalina con sistema di sicurezza è fondamentale che il contenitore venga utilizzato nel modo corretto: l'operatore addetto al prelievo è tenuto a verificare l'effettivo passaggio della formalina verso il campione istologico; in caso di scorretto utilizzo di tali barattoli, i campioni potrebbero giungere in laboratorio non fissati precludendo ogni possibilità di emettere una diagnosi corretta e adeguata. Si sottolinea l'importanza dell'invio in contenitori idonei al trasporto di campioni istologici per la sicurezza di tutti gli operatori coinvolti nel trasporto e nella processazione, oltre che per la sicurezza del campione che deve giungere con contenitore integro, non rotto o danneggiato, e completamente immerso in formalina a garanzia di una sua corretta fissazione per l'idoneità della diagnosi.

Per la sicurezza degli operatori addetti alla processazione del campione, si sottolinea l'importanza di non inserire nei contenitori alcun tagliente o pungente (aghi); nel caso sia necessario orientare il campione o identificarne una zona nello specifico si chiede di utilizzare solo filo di repere.

Qualora l'accettazione non avvenga tramite sistema interfacciato, è necessario compilare la scheda d'accettazione dedicata in tutte le sue parti.

Invio campioni istologici mammari (ago biopsie e pezzi operatori)

Qualora, in caso di positività, non fosse necessaria l'esecuzione del PANNELLO MAMMELLA (IN10260), è richiesto al Centro inviante di indicarlo nella scheda di accettazione o compilare nel sistema interfacciato il campo "note campione" indicando: IN CASO DI POSITIVITÀ NON È RICHIESTO PANNELLO RECETTORIALE.

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

Invio campioni istologici di ago biopsia prostatica

I campioni di ago biopsia prostatica prelevati su sedi multiple (mapping) devono essere inviati in singoli barattoli di formalina, ciascuno identificato con nome e cognome del paziente oltre che con la corretta sede del prelievo. È inoltre richiesto l'invio di barattoli contenenti al massimo 2-3 frustoli bioptici al fine di rispettare le linee guida definite da Epstein e Netto in "Biopsy Interpretation of the Prostate" secondo le quali l'accuratezza delle diagnosi è maggiore su campioni inviati singolarmente. Per numeri maggiori di frustoli viene richiesto l'invio in contenitori separati, ciascuno con la propria accettazione. Al fine di garantire una migliore fissazione del campione è inoltre sconsigliato inserire i frustoli in biocassette. preferendo quindi l'inserimento del materiale direttamente in formalina.

3. Invio e Trasporto

I campioni citologici ed i campioni istologici devono essere prelevati, inseriti ed inviati negli appositi contenitori. I contenitori con i campioni raccolti devono essere inseriti nell'apposita transbag rossa a chiusura sigillata con la specifica scheda di accettazione che deve essere riposta nella tasca laterale della bustina stessa. Onde evitare contaminazioni dei campioni è necessario utilizzare una transbag rossa piccola per ciascun campione.

Riporre tutte le transbag rosse contenenti campioni di Anatomia Patologica all'interno di buste rosse grandi, e compilare la bolla di trasporto recante il numero di identificazione del centro ed il numero dei campioni inviati. Le transbag grandi rosse sono a loro volta poste in bauli di plastica chiusi (contenitore primario A/B) per l'invio alla sezione Anatomia Patologica di Toscana Diagnostica.

Flusso degli step per la preparazione dell'invio dei campioni a Toscana Diagnostica

Step 1	**Step 2**	**Step 3**	**Step 4**
Preparazione del campione con le modalità descritte	Compilazione della scheda di accettazione e accettazione sul Sistema Informatico	Inserimento del campione nel Transbag rosso (inserimento della scheda nell'apposita tasca)	Ripetizione delle operazioni per tutti i campioni
Step 5	**Step 6**	**Step 7**	**Step 8**
Compilazione dell'apposita bolla con il riepilogo delle buste preparate	Verifica dell'inserimento di tutti i campioni raccolti	Preparazione del plico da consegnare alla Logistica con bolla di trasporto	Consegna del plico alla Logistica, nell'apposito contenitore di trasporto

Identificazione del Paziente (Scheda Cartacea)

In ogni richiesta devono essere riportati i seguenti dati indispensabili per una corretta esecuzione dell'esame:

- **cognome e nome**
- **data di nascita, luogo di nascita e codice fiscale**
- indirizzo di residenza/domicilio
- **medico richiedente**
- codice e nome della struttura inviante
- data del prelievo

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

- **tipo di materiale inviato**
- **notizie cliniche**

In caso di campione istologico è necessario specificare anche il tipo di prelievo o intervento effettuato e la sede anatomica. Si ricorda l'importanza di inviare campioni prelevati da sedi diverse (ad esempio 2 losanghe cutanee, un contenitore per cervice ed uno per utero, contenitori diversi per agobiopsie prostatiche indicando il lobo/quadrante del prelievo ecc.) in contenitori distinti e ben identificati al fine di emettere specifiche.

Identificazione dei campioni inviati tramite Sistema Informatico

Per effettuare l'accettazione/invio dei campioni tramite Sistema Informatico, si deve apporre la prima etichetta (generata dal programma) sulla scheda cartacea e la/e successiva/e sul/i contenitore/i del materiale biologico. Si ricorda l'importanza di inviare campioni prelevati da sedi diverse (ad esempio 2 losanghe cutanee in contenitori distinti e ben identificati al fine di emettere diagnosi complete; ogni contenitore deve quindi avere una propria etichetta identificativa, materiale, sede del prelievo e notizie cliniche.

In corso di inserimento nel programma utilizzare il campo "note specifiche del campione" per inserire natura e sede del materiale di ciascun campione, utilizzare il campo "note paziente sul referto" per le notizie cliniche che verranno poi pubblicate sul referto e utilizzare il campo "note richiesta" per eventuali comunicazioni interne da non riportare sulla diagnosi finale (campo da utilizzare solo eccezionalmente per comunicazioni particolari).

4. Tabella generale Campioni per Anatomia Patologica

Materiale	Metodo di Fissazione	Istruzione
Pap-test	1 vetrino fissato con citospray	Fissare immediatamente dopo il prelievo
Pap-test in fase liquida e HPV RNA	Contenitore Thin–Prep Pap Test da richiedere al nostro magazzino	Agitare bene il cytobrush nel contenitore in modo da causare il maggior distacco delle cellule e strisciarlo lungo le pareti, poi buttare il cytobrush. Fissare immediatamente dopo il prelievo
Citologico endometriale	1 vetrino fissato con citospray	Fissare immediatamente dopo il prelievo
Citologico endometriale in fase liquida	Contenitore Thin–Prep Pap Test da richiedere al nostro magazzino	Agitare bene il cytobrush nel contenitore in modo da causare il maggior distacco delle cellule e strisciarlo lungo le pareti, poi buttare il cytobrush. Fissare immediatamente dopo il prelievo
Urina	Contenitore Thin–Prep CytoLyt Solution da richiedere a magazzino	Urinare direttamente nel contenitore
Espettorato	Alcool 70-95° oppure Cytolyt solution	Quantità da coprire il materiale, oppure espettorare direttamente nel contenitore. Fissare immediatamente dopo

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

		il prelievo
Agoaspirato	Vetrini: strisciati e immersi in alcool 95%. Liquido: in Alcool 50% (in rapporto 1 a 1) oppure in Thin–Prep CytoLyt Solution da richiedere al magazzino, solo in presenza di quantità elevata di liquido utilizzare Cytolyt Solution	Quantità di alcool 50% pari al liquido prelevato. Fissare immediatamente dopo il prelievo
Liquidi di cavità corporee o di cisti	Liquido in Alcool 50% (in rapporto 1 a 1) oppure in CytoLyt Solution 30 mL da richiedere al magazzino	Quantità di fissativo pari al liquido prelevato. Fissare immediatamente dopo il prelievo
Secreto	Vetrini fissati con citospray	Fissare immediatamente dopo il prelievo
Secreto in fase liquida	Contenitore Thin–Prep CytoLyt Solution da richiedere al magazzino	Porre il materiale nel contenitore Thin Prep. Fissare immediatamente dopo il prelievo
Spazzolato, brushing, scraping	Vetrini: strisciati e immersi in alcool 95%	Fissare immediatamente dopo il prelievo
Spazzolato, brushing, scraping in fase liquida	Contenitore Thin–Prep CytoLyt Solution da richiedere al magazzino	Agitare bene il cytobrush nel contenitore in modo da causare il maggior distacco delle cellule e strisciarlo lungo le pareti, poi buttare il cytobrush. Fissare immediatamente dopo il prelievo
Istologici	Formalina al 10%	Per un volume 10 volte quello del pezzo. Fissare immediatamente dopo il prelievo

5. Allegato 1: Thin Prep

Il kit fornito da Toscana Diagnostica comprende il Cytobrush e la Spatola di AYRE per effettuare il prelievo e il contenitore dove stemperarlo.

 fig.1	Per effettuare il prelievo, utilizzare esclusivamente cytobrush e spatola presenti all'interno del kit. (non utilizzare spatole di legno)
Utilizzare la Spatola di Ayre (fig. 1) per il prelievo esocervicale mentre il Cytobrush (fig. 2) per il prelievo endocervicale. Una volta prelevato, il materiale citologico deve essere subito stemperato nell'apposito contenitore con 30 ml di liquido fissativo fornito da Toscana	 fig. 2

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

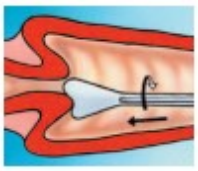
Diagnostica.	
	IMPORTANTE: non lasciare il cytobrush/spatola all'interno del contenitore. Il cytobrush e la spatola vanno scartati dopo l'utilizzo. I campioni prelevati vanno mantenuti e conservati a temperatura ambiente prima dell'invio e rimangono stabili anche oltre i 15 giorni. Scrivere con inchiostro indelebile nome, cognome e data di nascita della paziente sull'etichetta del contenitore e richiedere il ritiro del campione. Si ricorda che per l'esecuzione del PAP TEST è obbligatorio identificare il paziente mediante NOME, COGNOME, DATA DI NASCITA.

TOSCANA DIAGNOSTICA

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

ThinPrep® Pap TestQuick Reference Guide

Endocervical Brush and Spatula Protocol



Step 1

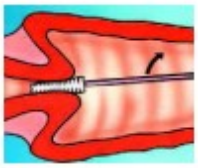
Using the **plastic spatula**, obtain an adequate sample from the ectocervix.



Step 2

Rinse the spatula as quickly as possible into the PreservCyt® Solution vial by swirling the spatula vigorously in the vial 10 times.

Discard the spatula.



Step 3

Using the **endocervical brush device**, obtain an adequate sampling from the endocervix.

Insert the brush into the cervix until only the bottommost fibers are exposed. Slowly rotate 1/4 or 1/2 turn in one direction. DO NOT OVER-ROTATE.



Step 4

Rinse the brush as quickly as possible in the PreservCyt Solution by rotating the device in the solution 10 times while pushing against the PreservCyt vial wall.

Swirl the brush vigorously to further release material, then discard the brush.



Step 5

Tighten the cap so that the torque line on the cap passes the torque line on the vial.



Step 6

Record:

- the patient's name and ID number on the vial.
- the patient information on the cytology requisition form.



Step 7

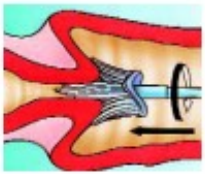
Place the vial and requisition in a specimen bag for transport to the laboratory.

TOSCANA DIAGNOSTICA

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

ThinPrep® Pap TestQuick Reference Guide

Broom-Like Device Protocol



Step 1

Obtain an adequate sampling from the cervix using a broom-like device.

Insert the central bristles of the broom into the endocervical canal deep enough to allow the shorter bristles to fully contact the ectocervix. Push gently, and rotate the broom in a clockwise direction five times



Step 2

Rinse the broom as quickly as possible into the PreservCyt® Solution vial by pushing the broom into the bottom of the vial 10 times, forcing the bristles apart. As a final step, swirl the broom vigorously to further release material.

Discard the collection device.



Step 3

Tighten the cap so that the torque line on the cap passes the torque line on the vial.



Step 4

Record:

- the patient's name and ID number on the vial.
- the patient information on the cytology requisition form.



Step 5

Place the vial and requisition in a specimen bag for transport to the laboratory.

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

6. Tabella generale dei campioni per Anatomia Patologica

Materiale	Metodo di fissazione	Istruzione
Pap-test in fase liquida e HPV RNA	Contenitore Thin Prep fornito dal magazzino TD	Agitare bene il cytobrush nel contenitore, NON lasciarlo dentro
Citologico endometriale	1 vetrino fissato con citospray	Fissare immediatamente dopo il prelievo
Citologico endometriale in fase liquida	Contenitore Thin Prep fornito dal magazzino TD	Agitare bene il cytobrush nel contenitore, NON lasciarlo dentro
Urina (citologico urinario)	Contenitore Cytolyt Solution fornito dal magazzino TD	Urinare direttamente nel contenitore
Espettorato	Alcool 70-95 gradi oppure Cytolyt Solution	Espettorare direttamente nel contenitore. Fissare immediatamente
Agoaspirato	Vetrini: strisciati e immersi in alcool 95%. Liquido: in alcool 50% (rapporto 1:1) oppure in Thin Prep	Fissare immediatamente dopo il prelievo
Liquidi di cavita corporee o di cisti	Liquido in alcool 50% (rapporto 1:1) oppure in Cytolyt Solution 30 mL	Fissare immediatamente dopo il prelievo
Secreto (convenzionale)	Vetrini fissati con citospray	Fissare immediatamente dopo il prelievo
Secreto in fase liquida	Contenitore Cytolyt Solution fornito dal magazzino TD	Porre il materiale nel contenitore. Fissare immediatamente
Spazzolato, brushing, scraping	Vetrini: strisciati e immersi in alcool 95%	Fissare immediatamente dopo il prelievo
Spazzolato, brushing, scraping in fase liquida	Contenitore Cytolyt Solution fornito dal magazzino TD	Agitare bene il cytobrush, NON lasciarlo dentro
Istologici (biopsie e pezzi operatori)	Formalina tamponata al 10%	Volume formalina 10 volte il volume del pezzo. Fissare immediatamente

7. Allegato: Kit Thin Prep

Il kit fornito da Toscana Diagnostica comprende il Cytobrush e la Spatola di Ayre per effettuare il prelievo e il contenitore dove stemperarlo. Utilizzare la Spatola di Ayre per il prelievo esocervicale e il Cytobrush per il prelievo endocervicale. Agitare bene il cytobrush e la spatola nel contenitore in modo da causare il maggior distacco delle cellule e strisciare lungo le pareti del contenitore. NON lasciare il cytobrush o la spatola all'interno del contenitore.

8. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione modifiche	Approvazione
00	14/04/2026	Prima emissione SGI	Francesco Epifani